

Kaygı Bozuklukları

Kaygı, aslında insanın tehlike karşısında kendisini korumasını sağlayan doğal bir duygudur. Ancak bu duygu gerçek bir tehlike olmadığı hâlde aşırı, yoğun ve kontrol edilmesi güç bir hâle geldiğinde kişinin yaşamını ciddi biçimde etkileyebilir. İşte bu durum kaygı bozukluklarını ortaya çıkarır. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre kaygı bozuklukları, 2021 yılında yaklaşık 359 milyon kişiyi etkileyerek dünyadaki en yaygın ruhsal bozukluk gruplarından biri olmuştur. Belirtiler çoğunlukla çocukluk veya ergenlik döneminde başlayabilir ve kadınlarda erkeklere göre daha sık görülür.

Kaygı bozukluğu yaşayan kişi yalnızca “endişeli” hissetmez. Yoğun korku ve sürekli endişeye; huzursuzluk, gerginlik, dikkatini toplamakta güçlük, uyku sorunları, kas gerginliği, terleme, titreme, mide bulantısı ve kalp çarpıntısı gibi fiziksel belirtiler de eşlik edebilir. Kişi çoğu zaman kaygısını azaltmak için kendisini rahatsız eden durumlardan kaçınmaya başlar. Bu kaçınma kısa vadede rahatlatıcı görünse de uzun vadede korkunun daha da güçlenmesine ve kişinin okul, iş, aile ve sosyal yaşamının kısıtlanmasına yol açabilir.

Kaygı bozuklukları tek bir hastalıktan ibaret değildir. Yaygın anksiyete bozukluğunda kişi günlük yaşamındaki birçok konu hakkında uzun süre ve aşırı düzeyde endişelenir. Panik bozukluğunda ise beklenmedik şekilde ortaya çıkan yoğun panik ataklar ve yeni bir atak geçirme korkusu ön plana çıkar. Bunun yanında sosyal ortamlarda yoğun değerlendirilme ve utanma korkusunun görüldüğü sosyal kaygı bozukluğu, belirli nesne veya durumlara karşı aşırı korkunun görüldüğü özgül fobiler, kaçmanın veya yardım almanın zor olabileceği yerlerden korkma ile karakterize agorafobi ve yakınlarından ayrılmaya yönelik aşırı korkunun görüldüğü ayrılık kaygısı bozukluğu da bu grubun içindedir.

Özellikle panik atak ile panik bozukluğu birbirinden ayrılmalıdır. Panik atak, birkaç dakika içinde zirveye ulaşabilen yoğun korku veya rahatsızlık nöbetidir. Kalp çarpıntısı, terleme, titreme, nefes darlığı, göğüs ağrısı, baş dönmesi,

uyuşma, mide bulantısı ve ölüm ya da kontrolü kaybetme korkusu gibi belirtiler oluşturabilir. Bu nedenle kişi bazen kalp krizi geçirdiğini veya öleceğini düşünebilir. Ancak tek başına bir panik atak geçirmek, kişinin mutlaka panik bozukluğu olduğu anlamına gelmez. Panik bozukluğunda atakların tekrarlaması ve kişinin en az bir ay boyunca yeni bir atak geçirmekten endişe etmesi veya ataklardan kaçınmak amacıyla davranışlarını değiştirmesi söz konusudur.

Kaygı bozukluklarının tek bir nedeni yoktur. Genetik yatkınlık, beyindeki korku ve kaygı ile ilişkili sistemler, psikolojik özellikler ve stresli veya olumsuz yaşam deneyimleri birlikte rol oynayabilir. Bu nedenle kaygı bozukluğu yaşayan bir kişiye yalnızca “fazla düşünüyorsun” demek doğru değildir. Aynı zamanda kaygı belirtileri bazı fiziksel hastalıklarla veya madde ve ilaç kullanımıyla da ilişkili olabilir. Örneğin tiroid hastalıkları, bazı kalp ve solunum sorunları, kafein veya bazı ilaçların kullanımı kaygıya benzer belirtiler oluşturabilir. Bu nedenle doğru tanı için belirtilerin yalnızca psikolojik açıdan değil, gerektiğinde fiziksel açıdan da değerlendirilmesi gerekir.

Tanıda kişinin yaşadığı belirtilerin ne zaman başladığı, ne kadar sürdüğü, ne sıklıkta ortaya çıktığı ve günlük yaşamını ne ölçüde etkilediği değerlendirilir. Yaygın anksiyete bozukluğunda aşırı kaygının en az 6 ay boyunca çoğu gün sürmesi ve kişinin kaygısını kontrol etmekte zorlanması önemli ölçütlerdendir. Panik bozukluğunda ise tekrarlayan ve beklenmedik panik ataklar ile bunların ardından gelişen sürekli endişe veya davranış değişiklikleri dikkate alınır. Depresyon, madde kullanım bozuklukları ve diğer ruhsal hastalıklar da sıklıkla eşlik edebildiğinden değerlendirme bütüncül yapılmalıdır.

Kaygı bozukluklarının önemli yanı, tedavi edilebilir olmalarıdır. En güçlü tedavi seçenekleri arasında psikoterapi ve gerektiğinde ilaç tedavisi bulunur. Özellikle bilişsel davranışçı terapi (BDT), kişinin kaygı yaratan düşüncelerini ve bu düşüncelere verdiği tepkileri fark etmesine, korktuğu durumlarla daha sağlıklı biçimde baş etmesine yardımcı olur. Panik bozukluğunda maruz bırakma ve özellikle bedensel duyumlarla kontrollü biçimde yüzleşmeyi içeren teknikler de

kullanılabilir. Gerekğinde SSRI ve SNRI grubu antidepresanlar etkili tedavi seçenekleri olabilir. Benzodiazepinler ise bağımlılık, tolerans ve yoksunluk gibi riskleri nedeniyle genellikle uzun süreli veya birinci basamak tedavi olarak tercih edilmez.

Sonuç olarak kaygı bozukluğu, kişinin “zayıf olması” veya “kafasında kurması” ile açıklanabilecek basit bir durum değildir. Korku sistemi gerçek bir tehlike yokken bile aşırı çalışabilir ve kişinin düşüncelerini, bedenini ve davranışlarını etkileyebilir. Fakat doğru değerlendirme, uygun psikoterapi, gerektiğinde ilaç tedavisi ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarıyla belirtiler kontrol altına alınabilir. Bu nedenle yoğun kaygı günlük yaşamı bozmaya başladığında bunu görmezden gelmek yerine profesyonel yardım almak, kişinin yaşam kalitesini yeniden kazanması açısından önemli bir adımdır.

Kaynaklar:

- 1) World Health Organization. (2025, September 8). *Anxiety disorders*.https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/anxiety-disorders?utm_source=chatgpt.com
- 2) National Institute of Mental Health. (2025). *Panic disorder: What is panic disorder?* U.S. Department of Health and Human Services, National Institutes of Health.https://www.nimh.nih.gov/health/publications/panic-disorder?utm_source=chatgpt.com
- 3) DeGeorge KC, Grover M, Streeter GS. Generalized Anxiety Disorder and Panic Disorder in Adults. *Am Fam Physician*. 2022 Aug;106(2):157-164. PMID: 35977134.

Ali Bocakkıtay/ Founder, Wionpav Labs/ Medical Student, Faculty of Medicine, Selçuk University